



DBT

MATERIAL DE APOIO · AULA 02 DE 12

Filosofia dialética: a base que sustenta a técnica

A dialética não chegou à DBT pela teoria: chegou pelo problema clínico de um tratamento que, focado só em mudança, fazia o paciente se sentir o próprio defeito.

ENCONTRO DE SÁBADO, 22 DE AGOSTO DE 2026 · 10H ÀS 12H
CONDUZIDO POR ANDRESSA JULIANA

DESCOMPLICANDO A DBT

Quem conduz a formação

Doze encontros ao vivo, aos sábados, para sair da leitura sobre DBT e chegar na condução da sessão — da teoria biossocial ao manejo de crise, com o pé na prática clínica.



IDEALIZADOR · PROFESSOR

Júlio Gonçalves



IDEALIZADORA · PROFESSORA

Andressa Juliana

Este material acompanha o encontro

As últimas páginas são preenchíveis: marque o checklist, responda as perguntas de revisão e guarde suas anotações no próprio arquivo. Salve depois de preencher.

O ESSENCIAL

- **A dialética não veio da teoria, veio do problema.** O foco exclusivo em mudança invalidava esses pacientes, e sessão e paciente viviam presos em polos opostos.
- **Dialética aqui é visão de mundo, não técnica.** Nada existe isolado, toda posição carrega o seu oposto, e a mudança é contínua e transacional.
- **Mudança é pílula amarga; validação é a cobertura de açúcar.** Só mudança, o paciente rejeita. Só aceitação, ele não chega onde quer ir.
- **A síntese não se explica, se pratica.** Não se psicoeduca dialética: o paciente a vivencia ao longo do tratamento.

01 Como a dialética entrou na DBT

O desenvolvimento começou no fim dos anos 70 e início dos 80, quando Linehan recebeu financiamento para testar se a terapia comportamental poderia ajudar mulheres entre 18 e 45 anos com episódios de autolesão e comportamento suicida. Numa reunião de financiamento, alguém apontou que aquele perfil correspondia ao transtorno da personalidade borderline — diagnóstico recém- formalizado no DSM-III. Sem diagnóstico, não havia financiamento.

A dialética entrou pelo mesmo caminho, pela prática. Linehan trabalhava por improviso, bebia da terapia familiar sistêmica e apontava paradoxos que apareciam na sessão. Uma psicóloga da equipe, casada com um filósofo marxista, disse a ela: *o teu tratamento é dialético*. Ela procurou a escola de filosofia da universidade, pediu aulas e construiu ali a base dialética do modelo.

O nome que não foi

Ela queria chamar o modelo de *terapia comportamental zen*. O editor do manual vetou: a associação com espiritualidade inviabilizaria a aceitação de um tratamento criado por uma mulher, nos anos 80 e 90, dentro de uma tradição comportamental que já o questionava.

02 A história que só veio em 2011

Linehan revelou publicamente suas próprias experiências com saúde mental apenas em 2011, depois que o tratamento já estava consolidado por estudos — para que a DBT não

fosse invalidada por sua história pessoal.

Vinha de uma família de classe média alta norte-americana muito atenta à aparência social, e era a filha diferente: questionadora, expressiva, frequentemente a mais criticada. Uma investigação médica por dores de cabeça terminou em internação psiquiátrica aos 18 anos; foram dois anos, com longos isolamentos e comportamentos autolesivos graves. Ao final desse período firmou o compromisso que organizou sua vida: sair daquele inferno e construir um tratamento para tirar outras pessoas do mesmo lugar. Nunca afirmou ter recebido diagnóstico de transtorno da personalidade borderline.

O QUE ELA DIZ SOBRE O PRÓPRIO MODELO

A DBT não é o melhor tratamento no sentido de ser o mais rápido ou o mais barato. É o melhor que existe hoje para esse público.

03 Os dois problemas que a dialética resolveu

A invalidação. Esses pacientes chegavam de tratamentos inteiramente focados em mudança e se sentiam como se o problema fossem eles, revivendo o ciclo de ter a dor tratada como não legítima. E saíam do tratamento.

A polarização. Terapeuta e paciente ocupavam polos opostos: um exigindo validação enquanto o outro puxava para a mudança — ou o inverso. A sessão travava ali.

04 As três premissas da visão dialética

Dialética é posição filosófica: não se comprova nem se rejeita. Resumida ao osso, diz que sempre existe mais de uma maneira de ver uma situação e mais de um modo de resolver um problema.

- **Interconexão e totalidade.** Nada existe isoladamente. Por isso não se pergunta por que o paciente fez isso, e sim o que estava acontecendo — base da análise em cadeia.
- **Polaridade.** Toda posição carrega o seu oposto. A verdade não está em nenhum dos extremos, e há um grão de sabedoria em cada um.
- **Mudança contínua e transacional.** Nada permanece igual. E é transacional, não apenas interacional: a interação pode se encerrar; a transação é o vaivém contínuo em que pessoa e ambiente se modificam mutuamente.

A consequência clínica

Sai-se da pergunta "de quem é a culpa" e entra-se na pergunta sobre o que está se retroalimentando ali e mantendo o comportamento.

05 Aceitação e mudança: a pílula e a cobertura

Para mudar, o paciente precisa aceitar a realidade como ela é — não se muda o que não se reconhece. E para aceitar, precisa acreditar que pode mudar. Aceitação é difícil porque não se pratica com o que é bom: pratica-se com o que dói.

As estratégias de mudança são uma **pílula de sabor amargo** que funciona; a validação é a **cobertura de açúcar** que torna possível engolir. Só mudança e o paciente rejeita; só aceitação e ele não vai a lugar nenhum.

06 Da polaridade à síntese

Um paciente diz que precisa parar de se cortar e diz também que cortar é a única coisa que funciona quando entra em crise. Dois extremos, polarização instalada. Três perguntas constroem a síntese: isso é efetivo? Qual é o grão de verdade em cada lado? Qual é o objetivo de ambos?

Na tese há verdade: o comportamento afasta da vida que ele quer e ele não tem outras ferramentas. Na antítese também: a função reguladora é real. E, olhando os dois, aparece o objetivo comum — ele quer parar de sofrer. É esse objetivo que sustenta a síntese.

NÃO PSICOEDUQUE DIALÉTICA

Swenson é direto: não se preocupe em fazer o paciente entender o conceito. Em algum momento você nomeia os dois polos, ele reconhece, e pronto. A síntese é coconstruída e provisória.

07 Os três modos e o risco de ficar preso num polo

Paradigma é a lente que orienta a prática — como a marcha do carro, que se troca conforme o terreno. O modo de aceitação valida; o modo de mudança persegue metas e solução de problemas; o modo dialético nasce da tensão entre os dois.

Quem vem da TCC costuma ficar preso no polo da mudança: foco em técnica, pouca avaliação, pressa em resolver. Com esses pacientes o efeito é o oposto do pretendido — mais resistência e mais sensação de invalidação. Quando a terapia empaca, provavelmente você está preso num polo e o paciente no outro.

08 Improviso, irreverência e o inesperado

A dialética é o que autoriza o terapeuta a improvisar — responder ao que acontece em tempo real, sem roteiro rígido. Swenson, primeiro terapeuta treinado em DBT fora do instituto, ouviu de Linehan que sua sessão parecia uma igreja, cuidadosa demais; a tarefa foi dizer ao paciente o que viesse à cabeça.

- **O inesperado.** Diante de quem se recusa a preencher o cartão diário: "então vamos falar sobre o quanto você odeia essa tarefa".
- **O silêncio.** Com um adolescente que não falava, ficar em silêncio junto e ver quem aguenta mais — e ele começou a se abrir.
- **Fazer do limão uma limonada.** De um término, além do sofrimento, pode sair a chance de se reconectar com valores. Sem invalidar a dor.
- **Advogado do diabo.** O terapeuta assume o polo desadaptativo para que o paciente defenda o próprio compromisso com a mudança.
- **Tolerar o paradoxo.** Alguém pode querer a sua felicidade e ao mesmo tempo não querer fazer o que te faria feliz. Não é preciso resolver.

Humor e irreverência entram pelo bem do paciente — nunca porque o terapeuta está com raiva. E o paciente que passou a escrever frases soltas no lugar do cartão diário está mais perto do objetivo do que estaria com o cartão em branco.

09 O que muda em relação à TCC

Na TCC, o pensamento polarizado é distorção a corrigir. Na DBT, as ideias opostas são duas verdades que coexistem, e a meta não é tornar o pensamento mais realista — é encontrar uma posição que incorpore as duas. Isso não proíbe reestruturação cognitiva; o que muda é a postura de entrada: em vez de procurar a distorção, perguntar qual é o grão de sabedoria e como validar.

Precisa ser DBT para todos os pacientes?

Não. Usar o modelo inteiro em qualquer caso é bala de canhão para alvo pequeno. Mas os princípios cabem em qualquer atendimento — é questão de repertório, não de fidelidade.

10 Os pressupostos da DBT

- Os pacientes estão fazendo o melhor que podem.

- Os pacientes querem melhorar — inclusive quando o comportamento parece dizer o contrário.
- A vida dos pacientes pode ser insuportável como está.
- Os pacientes precisam se esforçar mais e estar mais motivados a mudar. É dialético: as duas coisas são verdadeiras ao mesmo tempo.
- Podem não ter causado todos os seus problemas, mas são eles que precisam resolvê-los.
- Novos comportamentos devem ser aprendidos em todos os contextos relevantes.
- Os pacientes não podem falhar na terapia.
- Terapeutas que tratam esses pacientes precisam de apoio — daí o time de consultoria.
- Descobrir as causas do comportamento funciona melhor do que julgar e culpar.

11 Referências

- Linehan, M. M. (1993). *Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder*. Guilford Press. — capítulo 2, fundamentos dialéticos e biossociais.
- Linehan, M. M. (2015). *DBT skills training manual* (2ª ed.). Guilford Press. — fichas de efetividade interpessoal.
- Swenson, C. R. (2016). *DBT principles in action: Acceptance, change, and dialectics*. Guilford Press. — capítulo 5. Edição brasileira: *Terapia comportamental dialética em ação*.
- Linehan, M. M. (2020). *Building a life worth living: A memoir*. Random House. Edição brasileira: *Construindo uma vida que vale a pena ser vivida*.

NOTA DE MÉTODO

Resumo fiel à transcrição do encontro. Padronizei a grafia de Charles Swenson, que aparece na transcrição automática em variações. A menção ao DSM-III como o momento em que o diagnóstico se formalizou foi conferida e está correta. O livro de metáforas comentado em aula ficou sem referência porque a existência de edição em português não foi confirmada, assim como a indicação sobre o caminho do meio, citada em sala sem dados bibliográficos. Falas e exemplos trazidos por participantes foram mantidos de forma genérica, sem identificação, conforme o combinado de sigilo anunciado no início da aula.

Levar para a prática

Marque conforme experimentar em sessão. O arquivo guarda o que você preencher.

- ☐ Peguei as fichas de efetividade interpessoal e pratiquei o pensamento dialético na minha vida.
- ☐ No caso escolhido na aula 1, identifiquei uma tese e uma antítese que o paciente sustenta.
- ☐ Perguntei sobre esses polos: é efetivo? qual o grão de verdade? qual o objetivo comum?
- ☐ Observei em qual polo eu costumo ficar preso — e o que acontece com o paciente quando isso ocorre.
- ☐ Reparei em dialéticas do dia a dia: querer estar só e junto, controlar e tolerar a emoção.

Minhas anotações — o que levo para a clínica

Para revisar — resposta

Responda com suas palavras. O texto fica salvo no PDF.

01. Quais foram os dois problemas clínicos que levaram Linehan à dialética? Você já reconheceu algum dos dois em uma sessão sua?

02. Qual a diferença entre interação e transação — e por que a DBT insiste na segunda?

03. Escolha uma fala polarizada de um paciente seu. Escreva a tese, a antítese, o grão de verdade de cada uma e uma síntese possível.

04. Em que situação da sua clínica um improviso seria mais efetivo do que psicoeducar? O que faria dele um ato dialético?